

要がある。基本的には、酸素療法は正確な FiO_2 が確保できる高流量システム（ベンチュリーマスク）を用いる。高流量システムがない場合には、低流量システムである鼻カニューラを用いて、0.25～0.5 L/分から開始する。 PaCO_2 上昇による呼吸性アシドーシスの有無を動脈血ガスにて確認し、いきなり高濃度の酸素を投与せず、酸素化の目標を PaO_2 55 Torr 以上あるいは SpO_2 88% 以上とし、 PaCO_2 上昇による呼吸性アシドーシスおよび CO_2 ナルコーシスを回避するように酸素流量を調整する。それでもアシドーシスが悪化する場合には NPPV を選択する。最近では、軽症の II 型呼吸不全や NPPV が使用できない場合などに HFNC が用いられることもある。

Advanced

■ platypnea-orthodeoxia

platypnea-orthodeoxia とは、臥位から座位や立位になるとシャント量が増えて低酸素血症をきたす状態のことをいう。卵門孔開存、心房中隔欠損など心房内交通のある状態および心嚢水貯留や大動脈変形、瘤形成など、姿勢の変化で心房が変形する場合に右左シャントをきたす。肝硬変においても下肺での肺内シャント形成のため同様の病態を呈する場合がある。

文 献

- 1) 厚生省特定疾患「呼吸不全」調査研究班（横山哲朗班長）：昭和 54 年度研究報告書
- 2) 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会酸素療法マニュアル作成委員会、日本呼吸器学会肺生理専門委員会（編）：酸素療法マニュアル（酸素療法ガイドライン改訂版）、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会・日本呼吸器学会、2017
- 3) 日本呼吸器学会肺生理専門委員会（編）：臨床呼吸機能講習会テキスト、第 8 版、メディカルレビュー社、p59-61, 2016
- 4) West J: Respiratory Physiology—the essentials, Williams & Wilkins, 1974